

Fecha Última Actualización: 03-06-2022 9:24:43

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Maria Ines Roldán Roldán

Rut : 9.671.636-2

N° Archivo : 1620823

N° Epicrisis

309662

Edad : 78a 6m 7d

Fecha Nacto: 27/11/1943

Sexo : Femenino

Dirección : -Pasaje Fruto Oriente B/1658 D/104 V Noc

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 4219 2680

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Básica (4to Piso)

Fecha Ingreso : 16/05/2022 22:58

Días Estadía: 18

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 03/06/2022 09:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Cronología

Paciente grave, de cuidado.

Hospitalizada inicialmente en contexto de insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica por EPOC exacerbado e ICC descompensada, todo aparentemente por mala adherencia a tratamiento, que estando de salida, en resolución y estabilización de patología comienza con FA RVR, y luego compromiso de conciencia, cayendo además en falla ventilatoria, requiriendo IOT por la combinación de todos los factores.

Día 16 hospitalización

Día 10 UPC

Diagnósticos

Insuficiencia respiratoria aguda global

- ICC descompensada

- EPOC exacerbado debido neumonía aspirativa

Compromiso de conciencia toxico-metabólico.

ACV antiguos

- Infartos antiguos ACP derecha extenso

- Infartos antiguos limitrofe de ACM- ACP derecho

FA con RVR en control de frecuencia.

ICC descompensada

AKI KDIGO III / Fase anurica

Invasivos -> CVC 11, SF 11

Antibioticos -> Ampicilina Sulbactam 6°

Paciente grave, hemodinamicamente inestable, con requerimientos de Nad 0.17 ug/kg/min actualmente, asociado a Dobutamina y BIC Amiodarona esta ultima para control de frecuencia. Se mantiene con Fc 100-120 lpm, con apoyo de Dexmedetomidina para SAS 3-4, en bajas dosis para manejo de trastorno ansioso. En lo ventilatorio, completa 24 hrs en modalidad CPAP con PEEP 8 / PS 8. Vm 8 - 10 lpm. Intercambio gasometrico limitado con PaFI 200-220.

Fecha Epicrisis : 03/06/2022 09:24

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:34

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 03-06-2022 9:24:43

Página 2 de 3

Sin episodios febriles, en cobertura con ampicilina sulbactam de forma empírica.

En cuanto a balances destaco diuresis 660 cc/24 hrs con BH acumulado + 9.192 cc.

Nutrición enteral Diben 60 ml/hr con residuo gástrico escaso. Deposiciones presentes ayer. Tendencia a hiperglicemia con requerimiento de insulina correccional 22 U IC SC.

Hemodinamia: se mantiene con requerimientos de drogas vasoactivas principalmente Nad estacionaria 0.17 ug/kg/min y Dobutamina para efecto inotrópico, sin lograr importante mejoría de respuesta. Destaca ayer Hb 9 a 6.9 g/dL motivo por el cual se transfunde 1 U GR y aumenta Hb a 7.1 g/dL. Actualmente sin sangrado activo. Ayer presentó escasas secreciones serohemáticas por TOT.

Respiratorio: se mantiene con deterioro de intercambio gaseoso con PaFI 282 -> 206 -> 203. Se encuentra en modalidad espontánea con CPAP PEEP 8/PS 8-10. Por ahora se mantiene en modalidad respiratoria, KNTR para mejoría de esfuerzo respiratorio. En caso de deterioro clínico o mayor apremio ventilatorio evaluar paso a modalidad AC/P.

Renal: antecedente de Crea 1.2 (2020) con ERC etapa IIIb. En tercer día de tratamiento con albumina para mejoría de volumen intravascular efectivo con VEC muy aumentado. A pesar de apoyo con diuréticos horario post albumina, se mantiene oligúrica. Consultado con jefatura de módulo, se decide no candidato a TRR dado mala condición basal.

Neurológico: TAC de cerebro sin contraste con infartos antiguos embólicos de territorio extenso ACP derecha y limítrofe ACM-ACP del mismo lado, junto a imágenes de hiperdensidades puntiformes que siguen pequeños vasos sólo en hemisferio derecho (se plantea la sospecha de malformación vascular cerebral). Se descarta que lesiones a nivel frontal y parieto occipital derecha tengan rol de compromiso de conciencia pues presentaba anteriormente en 2017.

Evaluable por neurología, les impresiona que causa de compromiso de conciencia es hipoperfusión y tóxica metabólica. El plan es evaluar RNM de cerebro una vez más estable. No descartable nueva embolia cerebral.

Infeccioso: cursando con injuria infecciosa de foco pulmonar, con E coli MS (solo resistente a Ciprofloxacino), en septo día de terapia antibiótica afectiva. Hoy 6° día de AMP/SB y dos días previos con Imipenem. Si bien plan inicial corresponde a completar 7-10 días de Amp/Sb, destaco GB estacionarios con leve alza GB 18.650 a 18.690, PCR 38 a 54. Se conversa caso en conjunto, y a pesar de parámetros inflamatorios al alza, se decide no pancultivar nuevamente y mantener terapia actual dentro de manejo proporcional.

Tromboembólico: anticoagulación con BIC de heparina dado FA y trombo intraventricular presunto. ECO TE pendiente de realizar. Vigilancia de plaquetas destaco plaquetas 106.000. TTPK 42.

NO RCP

Pcte crítica, mala evolución global. Evoluciona con falla renal aguda oligúrica, anasarca, abundantes secreciones hemáticas con recurrentes episodios de desaturación. Mal acoplada al VMI, por lo cual se inicia BIC de sedoanalgesia con fentanyl quedando en modo PA/C con regular acople.

Durante la madrugada con desaturación asociada a hipotensión, requiriendo dosis supratérmicas de noradrenalina y FiO2 al 100%.

Se suspende BIC de amiodarona, dobutamina y heparina.

Se mantiene con soporte de DVA y VMI

Se avisa a familia sobre pronóstico ominoso. Pcte con patología cardíaca en fase terminal, evolucionando con falla orgánica múltiple: hemodinamia, respiratoria y renal.

Sin respuesta a manejo médico.

Presenta cese de signos vitales a las 9:15 am

Se constata fallecimiento.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda - falla orgánica múltiple

Fecha Epicrisis : 03/06/2022 09:24

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:34

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 03-06-2022 9:24:43

Página 3 de 3

Condición de Egreso: Fallecido
fallecimiento

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

María Valeria Medina Gatica
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 03/06/2022 09:24

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:34

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar